# リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月4日（水）

第53号　朝刊



きょうの紙面　▶脳卒中 × 認知リハ　▶呼吸リハ × リスク管理　▶制度 × 米国　▶短信 8本


■ 脳卒中 × 認知リハ

## 脳卒中後MCI、認知リハ併用で認知症の発症が少ない（HR 0.58）

米国の電子カルテ網・55歳以上を傾向スコアで照合　後ろ向き

脳卒中後6か月以内に軽度認知障害（MCI）が出た55歳以上を対象に、身体リハに認知リハを組み合わせた場合と身体リハだけの場合で、その後の認知症の発症を比べた後ろ向きコホート研究が掲載された（Archives of PM&R、11月号）。米国の多施設電子カルテ網TriNetXで、2010～2020年の脳卒中130,538人から絞り、傾向スコアでそろえた479人ずつを比べた。

発症6か月以降の認知症は、組み合わせた群で少なく、ハザード比は0.58（95%CI 0.40～0.84）だった。感度分析でも同じ向きで、男性やICUに入らなかった人の小集団でも似た関連だった。

後ろ向きの観察研究で、認知リハを受けられた人とそうでない人の背景の違いが残っている可能性があり、因果までは言えない。認知リハの中身や量は抄録では不明。回復期でMCIが見つかった人に、身体面の練習だけでなく認知面の介入も並べて考える根拠の一つになる。



MCIが見つかったら、認知面の介入も並べて考える。

出典 Archives of PM&R（2026年11月号）↗

**数字で見る**

**479人×2**
傾向スコアで照合した各群

**0.58**
認知症発症のハザード比

**0.40～0.84**
95%信頼区間

■ 呼吸リハ × リスク管理

## 間質性肺疾患の急性増悪中の呼吸リハ 3,986回で有害事象0.6%

間質性肺疾患の急性増悪で入院し呼吸リハを受けた295人を、国内5病院で82か月にわたり追った前向き観察研究。計3,986回のセッションで、あらかじめ決めた7種類の有害事象を記録した。有害事象は24件（0.6%）で、一過性の低酸素血症（SpO2 85%未満が3分超）が79.2%、低血圧12.5%、不整脈8.3%だった。



追加の治療や入院延長が必要になった例はない。有害事象が出た人は開始時の身体機能が低く、セッション数が多かった。対照群はなく、訓練を受けた理学療法士が手順に沿った条件での結果だ。

出典 Respirology↗

■ 制度 × 米国

## 脳卒中後リハ、IRFはSNFより 90日費用が低く効果も大きい

施設でのリハが必要な脳卒中患者を、集中的なリハを行う入院リハ施設（IRF）と高度看護施設（SNF）のどちらへ退院させるかで、90日の費用と効果を比べたモデル研究。IRFは平均費用が低く（43,062ドル対49,319ドル）、質調整生存年も大きく（0.57対0.37）、1人あたり6,257ドルの節約になった。



FIMの移動で意味のある改善に達する確率は60%対26%。既存データによるモデルで米国の制度の話だが、集中的なリハを費用だけで見ない材料になる。

出典 Archives of PM&R↗

**短信**

**〈失語〉軽い失語ほど疲労が強い**
慢性期の失語73人。失語が軽いほど脳卒中後の疲労が強かった（$\beta$=0.31）。重症度を問わず疲労の確認を。
出典 Archives of PM&R↗

**〈嚥下〉間欠的口腔食道経管と経鼻胃管**
脳卒中後嚥下障害54人のRCT。逆流リスクが低く経管の抜去成功も多い。主要評価の胃排出は差なし。
出典 Archives of PM&R↗

**〈サルコペニア〉AWGS 2025、補正法で判定差**
回復期の脳卒中864人。身長補正とBMI補正で21.2%の判定が食い違った（$\kappa$=0.578）。出典 PubMed↗

**〈栄養〉脳卒中後の悪液質と腸内細菌**
回復期の脳卒中130人の15%が悪液質。腸内細菌の多様性の低さと独立に関連。横断研究で仮説の段階。出典 PubMed↗

**〈心臓外科〉高齢者の周術期の呼吸筋訓練**
82人のRCT。術後肺合併症は38.1%対65.0%で少なく、吸気筋力の低下も減った。単施設の結果。
出典 Archives of PM&R↗

**〈切断〉下肢切断後の低栄養と転帰**
血管原性の大切断81人。低栄養は再切断なしの生存、QOL、6か月時点の移動能力の低さと関連した。
出典 Archives of PM&R↗

**〈ICU〉人工呼吸中の横隔膜電気刺激**
19RCT・1,437人の統合。人工呼吸期間は2.14日短いが、確実性は大半が低～非常に低い。出典 AJPMR↗

**〈糖尿病〉高齢2型糖尿病への運動、11RCT**
約740人。筋力（g=0.67）と身体機能（g=0.74）が改善、HbA1cは0.32低下。筋量は差なし。出典 PubMed↗